Protocole cicatrices – 20 min, 2 séances/semaine

PATIENT

Nom : _____ Date : _____ Localisation : _____

Type : [ ] Simple [ ] Fibrosée [ ] Adhérente [ ] Hypertrophique [ ] Chéloïde

OBJECTIFS

1. Assouplir la cicatrice et restaurer le glissement entre les plans.
2. Réduire l'induration, le prurit et la douleur.
3. Améliorer l'aspect, avec un suivi objectivé (Vancouver ou POSAS).

SÉCURITÉ

- Cicatrice fermée, sans croûte ni signe infectieux. Cicatrice chirurgicale récente : avis du chirurgien.
- Contre-indications générales : pacemaker ou implant électronique, grossesse (zone abdominale), tumeur, infection locale, thrombose.
- Arrêt ou réorientation si la cicatrice s'étend, devient inflammatoire ou plus douloureuse.
- Paramètres numériques : selon préréglages constructeur (LPG, Winback, Matim).

TRAME DE SÉANCE (20 MIN)

Temps	Étape	Contenu
0-2 min	Bilan flash	Palpation, test de décollement cutané, douleur/prurit. Photo et score à la 1re séance, puis toutes les 4 séances.
2-8 min	LPG Infinity	Mobilisation mécanique, fond de cicatrice et périphérie.
8-14 min	Winback 4 Care+	TECAR, mode et puissance adaptés au type de cicatrice.
14-19 min	Microlab (Matim)	Microcourant, intensité infrasensible.
19-20 min	Consignes	Hydratation, auto-massage, photoprotection.

ADAPTATION PAR TYPE DE CICATRICE

Type	LPG	Winback (TECAR)	Microcourant
Simple, mature	Mode continu, pression modérée	Capacitif doux	Entretien
Fibrosée	Plis cutanés et mobilisation transversale, pression progressive	Un peu plus soutenu si bien toléré	Sur la zone indurée
Adhérente	Plan de glissement en priorité	Assouplissement avant la mobilisation, 2 à 3 min	Ciblé sur l'adhérence
Hypertrophique	Pression faible	Athermique, faible puissance	Priorité
Chéloïde	Très doux, périphérie seulement	Athermique ou à éviter	Prudent, suivi de la dimension et de la douleur

SUIVI

- Ré-évaluation à 4 semaines (8 séances).
- Sans amélioration objective après 12 séances : orientation médicale (dermatologue ou chirurgien) pour les chéloïdes et les hypertrophiques.

NOTES CLINIQUES

TECAR sur chéloïde ou hypertrophique : aucun dosage thermique sûr établi par une source vérifiée, d'où l'athermique par prudence.

Niveau de preuve : l'endermologie induirait un remodelage de la matrice extracellulaire et une activation des fibroblastes (*Applied Sciences*, 2025, 15(8):4313), sans résultat clinique démontré sur cicatrices. TECAR et microcourant sur cicatrices : sources non vérifiées. Structure proposée à titre clinique, non validée en tant que protocole.